

1. Introducción y relevancia clínica

El **tapón de cerumen** es una de las causas más comunes de **hipoacusia conductiva reversible** y **otalgia** en atención primaria. Se estima que afecta entre un **5% y 10% de los adultos** y hasta un **30% de los adultos mayores**, especialmente en pacientes con uso de audífonos o limpieza excesiva del conducto auditivo externo (CAE).

Aunque su manejo parece trivial, el abordaje inadecuado puede generar **traumatismo, otitis externa, perforación timpánica o vértigo**. Por tanto, el médico general debe conocer su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento seguro, respetando las **guías clínicas MINSAL y las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología (SOCHIORL)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiología normal del cerumen

El **cerumen** es una mezcla de secreciones de las **glándulas ceruminosas y sebáceas** del tercio externo del CAE, junto con restos celulares. Su función es **protectora**, ya que:

- Mantiene un **pH ácido (4–5)** que inhibe el crecimiento bacteriano y fúngico.
- Atrapando polvo y microorganismos.
- Lubrica la piel del conducto, previniendo resequedad y fisuras.

El cerumen **se elimina espontáneamente** por el movimiento de migración epitelial hacia el exterior, ayudado por la masticación y movimientos mandibulares.

2.2 Formación del tapón

El **tapón de cerumen** se produce cuando se interrumpe la migración natural o se incrementa la producción. Los factores predisponentes son:

Factor	Mecanismo
--------	-----------

Limpieza excesiva con cotonitos	Empuja cerumen hacia el fondo del conducto
Audífonos, tapones o audífonos de natación	Obstruyen la salida natural
Conductos estrechos o tortuosos	Dificultan la migración epitelial
Cerumen seco o duro	Adherencia a piel y acumulación
Disminución de audición o movilidad mandibular	Menor expulsión fisiológica

El resultado es una **obstrucción parcial o total del CAE**, con alteración en la transmisión del sonido.

2.3 Tipos de cerumen

Existen dos fenotipos determinados genéticamente (gen **ABCC11**):

- **Húmedo:** color marrón oscuro, más común en caucásicos y africanos.
- **Seco:** gris amarillento, predominante en población asiática.

Ambos son fisiológicamente normales; el tipo no determina patología.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas frecuentes

- **Hipoacusia conductiva:** de inicio gradual o súbito.
- **Sensación de oído tapado o plenitud auricular.**
- **Autofonía** (escuchar la propia voz amplificada).

- **Prurito o molestia local.**
- **Tinnitus leve.**
- **Dolor (otalgia)** leve o ausente, salvo si hay otitis asociada.

En niños: irritabilidad, falta de atención, o baja en rendimiento escolar por hipoacusia.

En ancianos: causa reversible frecuente de pérdida auditiva.

3.2 Examen físico

Otoscopía:

- Conducto auditivo externo (CAE) **parcial o completamente ocupado** por material amarillento, marrón o negro.
- **Tímpano no visible.**
- Piel del conducto habitualmente indemne, sin signos inflamatorios.

Hallazgos diferenciales:

Diagnóstico	Características distintivas
Otitis externa	Dolor al traccionar pabellón, eritema y edema del conducto
Cuerpo extraño	Masa sólida, metálica o vegetal; historia evidente
Otitis media con efusión	Tímpano opaco o nivel hidroaéreo visible
Colesteatoma del CAE	Detritus blanco-amarillento con erosión ósea

3.3 Diagnóstico diferencial orientativo

Síntoma principal	Diagnóstico alternativo	Clave diferencial
Hipoacusia súbita	Hipoacusia neurosensorial	Rinne positivo, Weber lateraliza al sano
Otalgia	Otitis externa	Dolor al mover pabellón
Supuración	Otitis media o externa	Cerumen no supura

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico del tapón de cerumen es **clínico y visual**.

No requiere exámenes complementarios en la mayoría de los casos.

Sin embargo, pueden solicitarse en situaciones especiales:

Indicación	Examen sugerido	Propósito
Sospecha de otitis media concomitante	Otoscopía neumática o timpanometría	Valorar movilidad timpánica
Duda diagnóstica (hipoacusia persistente tras extracción)	Audiometría	Diferenciar tipo de pérdida auditiva
Sospecha de perforación timpánica previa	Otoscopía cuidadosa o microscopía	Contraindica irrigación

Criterios diagnósticos:

- Presencia visible de cerumen que **ocupa $\geq 80\%$ del conducto auditivo**.
- Correlación con síntomas auditivos reversibles tras extracción.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento busca **remover el cerumen de manera segura y restaurar la audición**, evitando daño al oído externo o medio.

Existen tres métodos principales:

5.1 Ablandamiento del cerumen (ceruminolíticos)

Primera línea según MINSAL.

Indicaciones:

- Tapón blando o adherente.
- Paciente sin perforación timpánica ni otitis externa.

Fármacos disponibles:

Sustancia	Presentación	Indicaciones / Observaciones
Glicerina o aceite mineral	3–5 gotas 2–3 veces al día por 2–5 días	Suave, bien tolerado
Peróxido de hidrógeno 3% o carbamida	Gotas otológicas comerciales	Eficaz, pero puede causar irritación o burbujeo
Solución salina o agua tibia	Alternativa económica	Menor eficacia

No usar: alcohol, éter o aceites esenciales, por riesgo de irritación cutánea.

5.2 Irrigación del conducto auditivo externo

Método más utilizado en APS.

Requisitos previos:

- Integridad timpánica confirmada por otoscopia.
- Ausencia de otitis externa o perforación.
- Agua tibia (37°C) para evitar vértigo o náuseas.

Técnica:

1. Paciente sentado, con toalla sobre hombro.
2. Utilizar jeringa tipo “pera” o jeringa de 50 mL con sonda plástica.
3. Dirigir el chorro hacia la pared posterior-superior del conducto, **nunca directamente al tímpano**.
4. Secar suavemente con gasa o aire templado.

Complicaciones posibles:

- Vértigo (por temperatura inadecuada).
- Dolor o sangrado.
- Perforación timpánica (si hay debilidad previa).
- Otitis externa secundaria (prevenir secando bien el conducto).

Profilaxis posterior:

- Aplicar 2–3 gotas de alcohol boricado o ácido acético diluido para acidificar y prevenir infección.

5.3 Extracción manual

Indicaciones:

- Tapón duro o muy adherente.

- Conducto estrecho o tortuoso.
- Paciente con antecedente de perforación timpánica o cirugía ótica.
- Irrigación contraindicada.

Método: con **ganchos auriculares, pinzas o curetas** bajo visión directa (preferentemente con microscopio).

Debe ser realizada por personal entrenado (idealmente otorrinolaringólogo).

5.4 En niños o pacientes no colaboradores

- Se puede usar ceruminolítico por varios días y repetir irrigación.
- En casos difíciles, derivar para extracción bajo visión o sedación.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Prevención
Dolor o sangrado	Irrigación brusca o mal dirigida	Chorro suave y dirigido lateralmente
Vértigo	Temperatura del agua fría o caliente	Usar agua a 37°C
Perforación timpánica	Exceso de presión o patología previa	Confirmar integridad del tímpano
Otitis externa	Humedad residual	Secar el conducto, usar gotas acidificantes

Reacumulación
frecuente

Hiperproducción o manipulación
excesiva

Educación sobre higiene
auricular

Pronóstico:

Excelente. La extracción completa del tapón **restaura inmediatamente la audición** y alivia los síntomas.

Las recurrencias son comunes, pero pueden prevenirse con educación y seguimiento.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **otalgia leve y la hipoacusia conductiva** son los síntomas más frecuentes del tapón de cerumen.
 2. Antes de irrigar, **confirmar siempre integridad timpánica**.
 3. El uso de **ceruminolíticos** es seguro y efectivo, especialmente en APS.
 4. **No usar cotonitos**: empujan el cerumen y pueden lesionar el conducto.
 5. Si persiste la hipoacusia tras extracción, realizar **audiometría**.
 6. En pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, evitar irrigación (riesgo de **otitis externa maligna**).
 7. La **educación del paciente** es parte del tratamiento.
-

Errores comunes

- Irrigar sin inspeccionar el tímpano.
- Usar agua fría (provoca vértigo).
- Diagnosticar “otitis” sin descartar tapón.
- Limpiar con cotonitos o pinzas sin visualización.

- No secar el conducto postirrigación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **tapón de cerumen** es una causa frecuente y reversible de hipoacusia conductiva.
2. Su formación se debe a **interrupción de la migración epitelial o manipulación inadecuada** del conducto auditivo.
3. El diagnóstico es **clínico**, mediante **otoscopía** que muestra obstrucción total o parcial del CAE.
4. El tratamiento consiste en **ceruminolíticos, irrigación o extracción manual**, según el caso.
5. **Nunca irrigar si hay sospecha de perforación timpánica o cirugía ótica previa.**
6. Las complicaciones son raras y prevenibles con técnica adecuada.
7. Educar al paciente: **no usar cotonitos**, mantener el oído seco y consultar ante recurrencias.